

나와 가족을 위한
이상지질혈증
예방과 관리 정보



나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보

이 자료는 이상지질혈증을 예방하고 관리하기 위해서 모든 국민이 실천해야 할 5대 생활 수칙과 실천 방법을 제시하고 있습니다. 올바른 생활 습관과 정기적인 검진을 통해 이상지질혈증을 예방하도록 합니다.



01



건강한 식습관을 가집니다



02



규칙적으로 운동합니다



03



적정 체중과 허리둘레를 유지합니다



04



금연합니다



05



절주합니다

근거 수준



낮음



보통



높음

「나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보」 소책자와 리플릿은 임상진료지침
정보센터(<http://www.guideline.or.kr>)에서 다운로드 받아 보실 수 있습니다.

CONTENTS

I. 이상지질혈증 소개	04
--------------	----

II. 이상지질혈증 예방과 관리 5대 생활 수칙	12
----------------------------	----

첫째, 건강한 식습관을 가집니다.	14
--------------------	----

둘째, 규칙적으로 운동합니다.	20
------------------	----

셋째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다.	24
-------------------------	----

넷째, 금연합니다.	28
------------	----

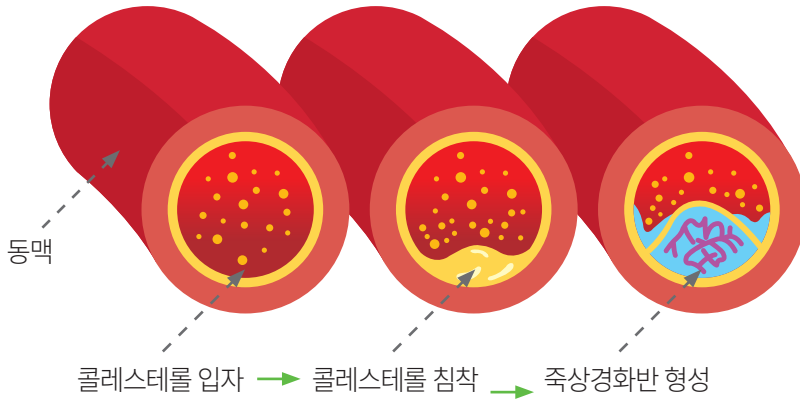
다섯째, 절주합니다.	32
-------------	----

III 부록	34
--------	----



이상지질혈증 소개

01 이상지질혈증이란?



이상지질혈증

‘이상지질혈증’이란 혈액 속의 지질(기름기)에 이상이 있다는 뜻입니다. 따라서 이상지질혈증은 혈액 속 콜레스테롤 수치에 이상이 생긴 것으로 다음 모두에 해당합니다.

- ① 나쁜 콜레스테롤(LDL-콜레스테롤)이 높은 경우
- ② 중성 지방이 높은 경우
- ③ 총콜레스테롤[나쁜 콜레스테롤(LDL-콜레스테롤) + 좋은 콜레스테롤(HDL-콜레스테롤) + 중성지방]이 높은 경우
- ④ 좋은 콜레스테롤(HDL-콜레스테롤)이 낮은 경우

나쁜 콜레스테롤[LDL(저밀도지질단백질)-콜레스테롤]이란?

혈액 내의 수치가 높을수록 동맥경화가 잘 생기는 콜레스테롤을 말합니다.

좋은 콜레스테롤[HDL(고밀도지질단백질)-콜레스테롤]이란?

혈액 내의 수치가 높을수록 동맥경화를 예방할 수 있는 콜레스테롤을 말합니다.

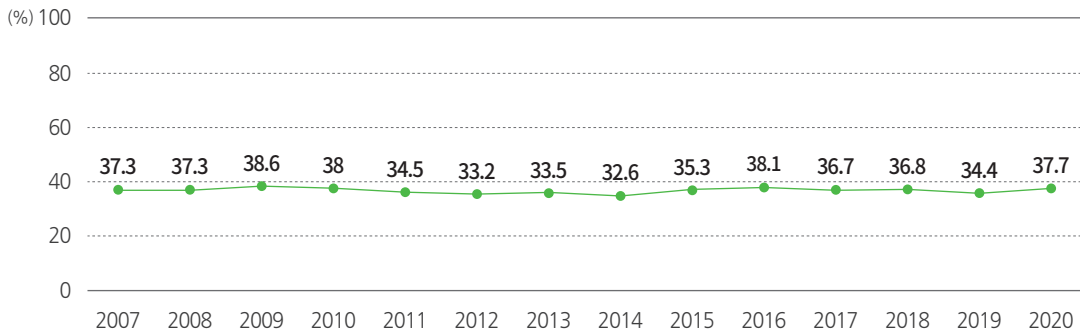
참고

사용자의 빠른 이해를 돕기 위하여 이후에 나오는 ‘나쁜 콜레스테롤(LDL-콜레스테롤)’은 ‘나쁜 LDL-콜레스테롤’, ‘좋은 콜레스테롤(HDL-콜레스테롤)’은 ‘좋은 HDL-콜레스테롤’이라는 표현을 사용함.

02 국내의 이상지질혈증 환자 현황

이상지질혈증은 우리나라 20세 이상의 성인 중 약 절반이 가지고 있을 정도로 흔한 질환입니다.

이상지질혈증의 유병률 연령표준화

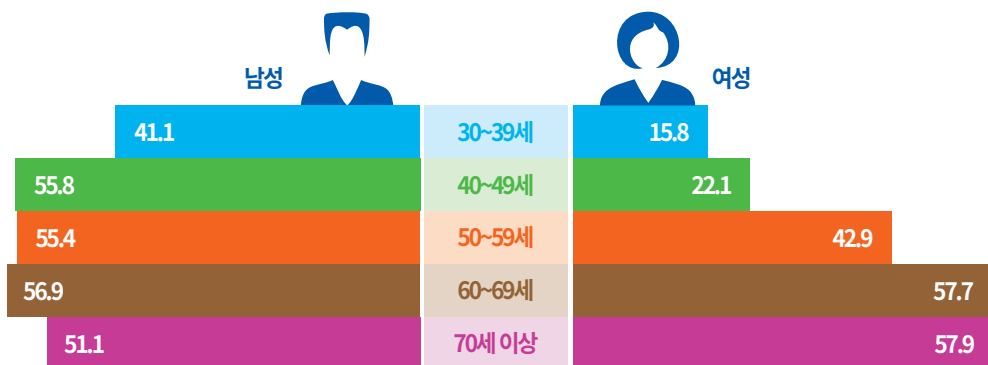


이상지질혈증 유병률 2007-2020 추이

자료원: 2007-2020 국민건강영양조사, 20세 이상 성인, 2005년 추계인구로 연령표준화

이상지질혈증: 고LDL콜레스테롤혈증, 고중성지방혈증, 또는 저HDL콜레스테롤혈증(남녀 모두 < 40 mg/dL)

연령별 유병률을 성별로 나누어 보면, 남성의 경우 전 연령대에서 대체적으로 두 명 중 한 명이 이상지질혈증을 가지고 있습니다. 그러나 여성의 경우에는 연령이 증가함에 따라 유병률도 따라서 증가하다가 폐경 이후의 50대 여성에서 남성과 마찬가지로 약 두 명 중 한 명 비율로 이상지질혈증을 가지고 있습니다.



연령과 성별에 따른 이상지질혈증 유병률 현황

(출처: 한국지질·동맥경화학회. Dyslipidemia Fact Sheet in Korea. 2022.)

03

이상지질혈증의 원인과 위험인자

원인

동물성 지방 섭취, 탄수화물 과다 섭취, 음주, 흡연, 스트레스, 운동 부족, 연령 증가 등이 이상지질혈증의 원인입니다.

위험인자

LDL - 콜레스테롤을 제외한 심혈관질환의 주요 위험인자¹⁾

연령	남자 ≥ 45세, 여자 ≥ 55세
관상동맥질환 조기 발병의 가족력	부모, 형제자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥질환이 발병한 경우
고혈압	수축기 혈압 140 mmHg 이상 또는 이완기 혈압 90 mmHg 이상 또는 항고 혈압제 복용
흡연	
저HDL 콜레스테롤	HDL 콜레스테롤 < 40 mg/dL

¹⁾ 고HDL 콜레스테롤(≥ 60 mg/dL)은 보호인자로 간주하여 총 위험인자 수에서 하나를 감하게 된다.
(출처: 한국지질·동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.)

04 이상지질혈증의 진단기준과 콜레스테롤 목표치

진단기준

이상지질혈증의 진단기준(위험인자가 없는 경우)

분류		단위 (mg/dL)
총콜레스테롤	높음	≥ 240
	경계치	200~239
	적정	< 200
중성지방	매우 높음	≥ 500
	높음	200~499
	경계치	150~199
	적정	< 150
좋은 HDL-콜레스테롤	높음	≥ 60
	낮음	< 40
나쁜 LDL-콜레스테롤	매우 높음	≥ 190
	높음	160~189
	경계치	130~159
	정상	100~129
	적정	< 100

콜레스테롤 목표치

심혈관 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 및 non-HDL 콜레스테롤의 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	non-HDL 콜레스테롤 (mg/dL)
관상동맥질환 ^{1)*}	< 55	< 85
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성 뇌허혈발작* 경동맥질환* 말초동맥질환* 복부대동맥류* 당뇨병(유병기간 10년 이상 또는 주요 심혈관질환 위험인자 [†] 또는 표적장기손상을 동반한 경우) ²⁾	< 70	< 100
당뇨병(유병기간 10년 미만, 주요 심혈관질환 위험인자 [†] 가 없는 경우)	< 100	< 130
중증도 위험군(주요 심혈관질환 위험인자 [†] 2개 이상)	< 130	< 160
저위험군(주요 심혈관질환 위험인자 [†] 1개 이하)	< 160	< 190

* LDL 콜레스테롤 기저치 대비 50 % 이상 감소시키는 것을 동시에 권고

[†] 연령(남자 ≥ 45세, 여자 ≥ 55세), 조기 심혈관질환 발생 가족력, 고혈압, 흡연, 낮은 HDL 콜레스테롤 수치(<40 mg/dL)

¹⁾ 급성심근경색증은 기저치 LDL 콜레스테롤 농도와 상관없이 스타틴을 투약

²⁾ 표적장기손상(알부민뇨, 만성콩팥병(추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만), 망막병증, 신경병증, 좌심실비대) 또는 3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자[†]를 동반한 당뇨병의 경우: LDL 콜레스테롤 목표치 < 55 mg/dL 선택적 고려 가능 (출처: 한국지질·동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.)

05

이상지질혈증의 증상과 합병증

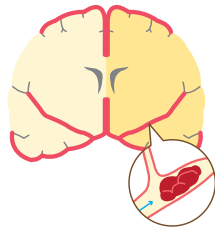
증상과 합병증

이상지질혈증은 특별한 증세를 보이지 않는 경우가 대부분입니다. 그렇지만 조절하지 않고 장기간 방치하면 콜레스테롤이 혈관 벽에 쌓여 혈관을 좁히거나 막아 협심증, 심근경색, 뇌졸중(뇌경색)과 같은 심뇌혈관질환을 일으킬 수 있습니다.

국내에서 보고된 심뇌혈관질환의 위험인자를 살펴보면, 남성의 경우 고혈압, 흡연, 이상지질혈증이, 여성의 경우 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병, 흡연이 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 이상지질혈증은 남녀 모두에게서 심뇌혈관질환을 일으킬 수 있는 위험인자인 것입니다.



허혈성 심장질환	
협심증/심근경색증	
증상	심한 흉통, 호흡 곤란, 급사



뇌혈관질환	
중풍/뇌졸중(뇌경색)	
증상	어지럼증, 사지 마비, 실어증

자주하는 질문

Q

심뇌혈관질환 환자는 모두 콜레스테롤이 높은가요?

A

콜레스테롤이 높아지면 이것이 혈관 벽에 쌓여 혈관을 좁히거나 막게 됩니다. 이로 인해 동맥 경화의 위험성이 높아지면서 결국 심뇌혈관질환의 발생 위험도 높아지게 됩니다. 하지만 심뇌혈관질환 환자라고 해서 모두 콜레스테롤이 높은 것은 아닙니다. 반대로 콜레스테롤이 높다고 모두 심뇌혈관질환에 걸리는 것도 아닙니다.

심뇌혈관질환(동맥경화성)을 일으키는 데에는 콜레스테롤이 높은 것 외에도 다양한 원인이 있습니다. 당뇨병, 비만, 고혈압, 운동 부족, 흡연, 유전적 요인 등이 모두 심뇌혈관질환의 위험인자가 됩니다. 그렇지만 이런 위험인자 중에서도 특히 콜레스테롤이 높은 것이 남녀 모두에게 심뇌혈관질환을 일으키는 가장 큰 원인입니다.

Q

중성 지방이 높으면 LDL-콜레스테롤이 높지 않아도 위험한가요?

A

중성 지방이 높은 경우 보통 LDL-콜레스테롤도 높습니다. 그러나 중성 지방이 높은데도 LDL-콜레스테롤이 높지 않은 경우가 있는데, 알코올 의존성으로 술을 많이 마시는 경우에 특히 그렇습니다.

중성 지방이 높으면 간에 있는 지방 분해 효소의 활성이 증가하여 상대적으로 작고 치밀한 LDL 입자가 많이 생깁니다. 혈액 내에서 작고 치밀한 LDL 입자는 크기가 큰 LDL-콜레스테롤 입자에 비하여 혈관 벽을 뚫고 그 속으로 잘 들어가기 때문에 쉽게 동맥경화증을 유발하게 됩니다. 그러므로 비록 나쁜 LDL-콜레스테롤이 높지 않다고 해도 중성 지방이 높으면 결과적으로 혈관 속에 나쁜 LDL-콜레스테롤을 증가하게 하여 동맥경화증을 일으킬 가능성이 커집니다. 이뿐만 아니라 중성 지방만 단독으로 상당히 높은 경우에는 급성 췌장염의 위험도도 올라가게 됩니다.

자주하는 질문

Q

당뇨병 치료 중인데 이상지질혈증이 있다고 합니다. 이 경우 이상지질혈증 치료를 꼭 해야 하는지, 치료를 한다면 콜레스테롤 수치를 어느 정도로 낮춰야 하나요?

A

당뇨병은 심뇌혈관질환의 중요한 위험인자 중 하나입니다. 당뇨병 환자에게 이상지질혈증은 흔히 나타나는 질환입니다. 이상지질혈증이 없다가도 혈당 조절이 잘 안되면 새로 발생하기도 하고 이미 이상지질혈증이 있는 경우라면 이것이 더욱 악화되기도 합니다. 그러므로 당뇨병 환자가 이상지질혈증을 보일 경우 환자에게 심뇌혈관질환이 발생할 가능성이 커집니다. 따라서 당뇨병 환자가 이상지질혈증을 보일 경우 단순 이상지질혈증을 보이는 환자보다도 콜레스테롤을 더 잘 관리해야 합니다. 당뇨병 환자는 일반적으로 나쁜 LDL-콜레스테롤을 100 mg/dL 미만으로 유지하도록 하고, 이미 심뇌혈관질환의 병력이 있으면 70 mg/dL 미만까지 낮추도록 권고하고 있습니다. 이 목표치에 도달하기 위해서는 적극적인 생활 습관 개선과 약물 치료가 필요한 경우가 많습니다.

Q

이상지질혈증 약을 먹으면 당뇨병이 잘 생긴다고 하는데, 치료약을 계속 먹어야 할까요?

A

최근 콜레스테롤을 낮추는 약인 스타틴이 당뇨병의 발생을 증가하게 한다는 연구 결과가 있었습니다. 하지만 새롭게 당뇨병이 발병하는 경우는 대체로 약 복용 전에 이미 당뇨병의 경계선에 있었던 경우가 많습니다. 또한 고용량의 스타틴을 복용하는 경우에 당뇨병이 더 많이 발생하기도 합니다. 이처럼 당뇨병이 새로이 발생한다고 해도 스타틴은 당뇨병이 없는 환자들에게 작용하는 것과 마찬가지로 심뇌혈관질환을 예방하는 효과가 있습니다. 따라서 스타틴이 설사 당뇨병 발생의 위험을 약간 증가시킨다고 해도, 심뇌혈관질환을 예방하는 이득이 훨씬 더 크므로 약을 계속 복용하도록 권고합니다. 다만 당뇨병 전 단계에 있는 경우는 약을 복용하면서 당뇨병으로 진행할 위험성이 높기 때문에 운동, 금연, 적정 체중 유지 등과 같이 생활 습관을 개선하여 당뇨병을 예방하는 데 더욱 신경을 써야 합니다.



이상지질혈증 예 방 과 관 리 5대 생활 수칙



01



건강한 식습관을 가집니다



02



규칙적으로 운동합니다



03



적정 체중과 허리둘레를 유지합니다



04



금연합니다



05



절주합니다

근거 수준



낮음



보통



높음

본 생활 수칙을 도출하고 제시하기 위해 참고한 국내외 학술지 게재 논문 등을 바탕으로 어떻게 연구가 설계되었는지에 따라 근거 수준을 높음, 보통, 낮음으로 표기하였습니다.

[참고]

높음: 체계적 문헌고찰, 대조군이 있는 임상 연구

보통: 코호트 연구, 환자-대조군 연구

낮음: 대조군이 없는 단면 연구, 전문가 의견

01

첫째, 건강한 식습관을 가집니다.

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 포화 지방과 트랜스 지방 섭취를 줄입니다.
- 좋지 않은 지방(포화 지방)을 좋은 지방(불포화 지방)으로 대체하여 섭취합니다.
- 매일 영양소를 골고루 섭취하는 균형 잡힌 식사를 합니다.



관련 상식 들여다보기

- 포화 지방과 트랜스 지방을 많이 먹으면 나쁜 LDL-콜레스테롤과 중성 지방이 증가하여 동맥경화성 심뇌혈관질환이 생길 수 있습니다.
- 전체 지방의 양보다는 좋지 않은 지방(포화 지방)을 좋은 지방(불포화 지방)으로 대체하여 섭취하는 것이 가장 중요합니다. ‘모든 지방은 나쁘다’는 생각에 지방 섭취를 줄이고, 설탕, 흰 빵, 흰 쌀, 밀가루, 감자와 같은 탄수화물 섭취를 늘리는 것이 오히려 체중을 증가하게 하고 혈중 콜레스테롤을 증가하게 하여 건강에 좋지 않은 영향을 주게 됩니다.
- 섬유소가 많은 잡곡류와 신선한 야채를 충분히 먹습니다.

포화 지방과 트랜스 지방 섭취를 줄입니다.

- ▶ 포화 지방이 많은 음식의 섭취를 줄입니다.
 - 소고기, 돼지고기, 양고기 등 육류의 지방
 - 닭, 오리의 껍질 부위
 - 달걀노른자
 - 우유, 치즈, 아이스크림 등의 유제품
 - 코코넛유(초콜릿), 팜유(커피 크림, 라면, 과자류), 야자유, 버터
- ▶ 트랜스 지방이 많은 음식의 섭취를 줄입니다.
 - 마가린, 쇼트닝 등의 경화유
 - 높은 온도로 오랜 시간 처리한 기름이나 과자

좋지 않은 지방(포화 지방)을 좋은 지방(불포화 지방)으로 대체하여 섭취합니다.

- ▶ 불포화 지방이 들어 있는 음식을 충분히 섭취합니다.
 - 올리브유, 카놀라유, 아보카도유
 - 옥수수유, 대두유, 홍화씨유, 해바라기씨유, 포도씨유, 달맞이꽃씨유
 - 생선(고등어, 연어, 꽁치, 청어, 참치 등), 해산물
 - 참기름, 들기름, 호두 기름, 땅콩 기름
 - 견과류
- ▶ 콜레스테롤 조절에 도움이 되는 음식을 섭취합니다.
 - 콜레스테롤 조절에 도움이 되는 음식은 나쁜 LDL-콜레스테롤과 중성 지방 수치를 낮추어 주고, 좋은 HDL-콜레스테롤을 높여 줍니다.

TIP 콜레스테롤 조절에 도움이 되는 음식

오메가3 불포화 지방	등 푸른 생선(고등어, 꽁치, 정어리 등)
오메가6 불포화 지방	견과류(땅콩, 호두 등)
식물성 기름	콩기름, 들기름, 올리브유 등
식이 섬유	잡곡이나 현미, 통밀 등의 통곡 식품, 해조류, 채소, 과일 껍질

실천 방법 알기

매일 영양소를 골고루 섭취하는 균형 잡힌 식사를 합니다.

▶ 매일 세끼 식사를 규칙적으로 합니다.

- 식사를 거르지 말고 제때 적당량의 식사를 하는 것을 습관화합니다.

▶ 밥과 함께 다양한 반찬을 먹으며 균형 잡힌 식생활을 합니다.

- 곡류, 채소, 과일류, 생선류, 유제품 등 다양한 식품군을 골고루 섭취합니다.
- 탄수화물 섭취량이 과다하지 않도록 하며, 쌀밥 대신 잡곡밥을, 식빵 대신 잡곡빵을 먹습니다.
- 비타민과 무기질, 식이 섬유가 풍부한 여러 가지 색깔의 채소와 다양한 체철 과일을 매일 먹습니다.
- 우유, 치즈, 요거트와 같은 유제품을 간식으로 섭취합니다.
- 술은 피합니다.

TIP 이상지질혈증의 예방과 관리를 위한 식사 지침

	고려해 주세요	이런 식사가 좋습니다	많이 먹지 않습니다
	섬유소가 많은 잡곡류를 먹습니다.	· 잡곡밥, 현미밥, 보리밥 등	· 흰쌀밥, 빵, 케이크 등
	염분이 적은 맑은 국을 소량 먹습니다.	· 콩나물국, 두부, 근대 된장찌개, 된장국, 북엇국, 동태국 등	· 염분이 많은 찌개류 · 크림 스프
	포화지방의 함량이 적은 생선과 소고기, 돼지고기, 닭고기 등의 살코기 부위를 주로 먹습니다.	· 생선 · 지방을 제거한 소고기, 돼지고기, 양고기 등의 살코기 · 껍질을 벗긴 가금류 · 달걀흰자 · 찜, 구이, 조림 요리 · 고등어 무 조림, 병어 조림, 동태전, 닭찜, 소고기 불고기, 달걀흰자 찜 등	· 삼겹살, 갈비, 껍질째 튀긴 닭, 내장류(곱창 등), 알류(달걀 노른자, 생선알 등) · 육가공품(햄, 소시지, 베이컨) · 튀김 요리
	신선한 야채를 충분히 먹습니다.	· 시금치, 호박, 도라지, 오이 등의 신선한 야채로 만든 반찬 (시금치나물, 오이 부추 겹절이, 오이 생채, 깻잎 무침, 호박나물, 도라지 생채, 참나물 무침 등)	
	충분히 먹되, 중성지방이 높거나 비만인 경우에는 많이 먹지 않습니다.	· 사과, 귤, 배 등의 신선한 과일	
	저지방, 기름기를 뺀 제품을 먹습니다.	· 저지방 우유, 저지방 치즈 · 탈지유	· 일반 우유, 연유, 요거트, 치즈, 크림치즈, 아이스크림
	포화 지방의 섭취는 줄이고, 불포화 지방을 먹습니다.	· 들기름, 올리브유 등의 식물성 기름 · 견과류(땅콩, 호두)	· 버터, 코코넛유, 아자유, 쇼트닝, 마요네즈, 마가린

자주하는 질문

Q

고기를 잘 먹지 않는데 콜레스테롤이 높은 이유가 뭘까요?

A

우리 몸의 콜레스테롤은 음식 섭취를 통해서 얻어지기도 하지만 간에서도 콜레스테롤을 생성해 냅니다. 이처럼 몸 안에서 바로 만든 콜레스테롤이 전체 콜레스테롤의 70~80% 정도로 많고, 음식을 통해서 얻어지는 비율은 20~30% 정도로 비교적 적은 편입니다. 즉, 음식을 통한 콜레스테롤의 흡수보다는 간에서 콜레스테롤이 많이 만들어지는 것이 더 문제가 될 수 있습니다. 따라서 고기를 잘 먹지 않는다 하더라도 콜레스테롤이 몸 안에서 많이 만들어지는 경우라면 콜레스테롤 수치가 높을 수 있습니다.

Q

성인병 예방을 위해 육식을 피하고 채식을 해야 하나요?

A

당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증으로 대표되는 성인병은 고포화 지방, 고칼로리 음식의 섭취와 연관이 있습니다. 이에 포화 지방이 많은 육식은 피하고, 식이 섬유소가 많이 함유된 식사를 하도록 권하고 있습니다. 하지만, 채식 위주로만 식사를 하게 되면 단백질 등 우리 몸에 필수적인 영양소가 부족해져 건강에 문제를 일으킬 수 있습니다.

또한 채소 반찬과 밥 등 식물성으로만 구성된 식사를 하면 상대적으로 당질(탄수화물) 섭취량이 많아지는데, 당질 섭취가 과다해지면 중성 지방의 수치를 증가시킬 수 있습니다. 따라서 이상지질혈증 환자도 양질의 단백질을 적당히 섭취해야 합니다. 다만 소고기나 돼지고기를 먹는 횟수를 줄이고, 그 대신 닭고기, 등 푸른 생선, 콩, 두부 등으로 단백질을 보충하는 것이 좋습니다. 또한 고기를 먹을 때에는 기름을 최대한 제거하는 것이 좋습니다.

자주하는 질문

Q

건강기능식품이 부작용도 적고 신체에 부족한 성분도 보충해 준다는데 실제로 이런 식품의 섭취가 건강에 도움이 되나요?

A

건강기능식품(건강보조식품)은 일반 식품의 형태와는 확연히 구별되는 모양을 하고 있으며, 식품에서 특정 기능성 성분만을 분리해서 농축한 형태이므로 일반 식품과 같다고 생각해서는 안됩니다. 건강기능식품에는 특정 성분의 양이 일반 식품을 통해 섭취할 수 있는 양의 수십 배에서 수백 배 가까이 들어 있습니다. 게다가 건강기능식품은 대체로 지속적으로 복용하는 경우가 많아서 결과적으로 특정 성분을 오랜 기간 다량 복용하게 됩니다. 이런 경우에 부작용이 나타날 수 있습니다. 또한 식사를 통해 섭취한 영양 성분과 상호작용을 일으켜 전체적인 영양 상태에 좋지 않는 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히 질병으로 치료를 받는 환자들이 건강기능식품을 복용할 경우에 치료를 위해 사용되는 약과 여러 가지 상호작용을 일으켜 예기치 않았던 문제가 발생하기도 합니다. 건강기능식품에 대해 지나친 기대는 하지 않는 것이 좋고, 특히 질병으로 치료를 받는 경우에는 반드시 담당 의사와 복용에 대해 상의하는 것이 좋겠습니다.

Q

트랜스 지방이 무엇인가요?

A

트랜스 지방은 인공적으로 만든 지방의 일종으로 트랜스 지방산(트랜스형 분자 구조의 불포화 지방산)과 글리세롤이 결합한 것을 말합니다. 세계보건기구(WHO)에서는 하루에 섭취하는 칼로리 중에서 트랜스 지방의 비율이 1% 미만인 되도록 권고하고 있습니다. 트랜스 지방은 각종 혈관 질환을 일으키는 나쁜 지방이므로 식품을 고를 때 항상 식품에 표시된 영양 성분표를 확인하여 트랜스 지방이 적거나 없는 것을 선택하는 것이 좋습니다. 2015년 미국 식품 의약품 안전청에서는 3년의 유예 기간을 두고 트랜스 지방의 사용을 완전히 금하도록 하였습니다. 트랜스 지방은 주로 포테이토칩, 크루아상, 튀김 음식, 파이, 비스킷, 아이스크림, 과자, 푸딩 등에 사용됩니다.

자주하는 질문

Q

식물성 기름은 많이 먹어도 안전한가요?

A

식물성 기름도 기름의 종류에 따라서 혈중 콜레스테롤을 증가시킬 수 있습니다. 일반적으로 콩기름, 옥수수유, 올리브유, 참기름, 들기름 등은 불포화 지방의 함량이 높기 때문에 혈중 콜레스테롤을 낮추는 작용을 합니다. 하지만, 식물성 기름 중에서 포화 지방을 많이 함유하고 있는 팜유, 코코넛유는 콜레스테롤을 높이는 작용을 합니다. 마가린은 식물성 기름이고 불포화 지방의 함량이 높지만 마가린의 불포화 지방은 트랜스 지방산의 형태이기 때문에 섭취를 피해야 합니다. 결론적으로 이상지질혈증 환자는 총 지방 섭취량을 제한하면서 특히 포화 지방을 중심으로 섭취 비율을 낮추는 것이 좋습니다.

Q

고기나 달걀을 전혀 먹지 않아야 하나요?

A

전체 지방의 양을 제한하는 것도 중요하지만 좋지 않은 지방(포화 지방)을 좋은 지방(불포화 지방)으로 대체하여 섭취하는 것에 더 신경을 써야 합니다. ‘모든 지방은 나쁘다’는 생각에 지방의 섭취를 줄이고, 설탕, 흰 빵, 흰 쌀, 밀가루, 감자와 같은 탄수화물이 많이 함유된 식품의 섭취를 늘리면 오히려 체중이 늘고 혈중 콜레스테롤도 높아져 건강에 좋지 않은 영향을 주게 됩니다. 지방은 칼로리가 높으므로 지방을 많이 섭취하면 비만해지기 쉽지만 그렇다고 해서 지방을 전혀 먹지 않아야 한다는 것은 아닙니다. 오히려 적절한 지방의 섭취는 건강에 필수적입니다. 또한 이상지질혈증 환자의 경우에 양질의 단백질을 적당히 섭취할 필요가 있습니다. 달걀은 콜레스테롤 함유량이 많지 않아 일주일에 두 개 정도 먹을 경우 혈중 콜레스테롤 농도에 큰 영향을 미치지 않으니 완전히 피할 필요는 없습니다. 그리고 콜레스테롤이 높다고 알려진 오징어, 새우 등도 자주 혹은 한꺼번에 많이 먹는 것이 아니라면 가끔 섭취하는 것 정도는 괜찮습니다.

둘째, 규칙적으로 운동합니다.

02

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 규칙적으로 운동을 합니다.
- 일상생활 속에서 신체 활동을 늘립니다.



관련 상식 들여다보기

- 약간의 운동이라도 하는 것이 전혀 운동을 하지 않는 것보다는 혈중 지질대사 개선과 건강에 도움이 됩니다. 또한 규칙적으로 운동하면 이상지질혈증과 심뇌혈관질환을 예방할 수 있습니다.
- 유산소 운동은 신체의 산소 소비량을 증대시키는 운동입니다. 빠르게 걷기, 조깅, 수영, 자전거 타기와 같은 유산소 운동을 30분 이상 하면 좋습니다. 비만을 예방하고 근력을 키우기 위하여 무산소 운동도 적절하게 시행해야 합니다.
- 건강한 성인이 중간 강도 이하의 유산소 운동을 시작할 때는 문제가 없습니다. 그러나 나이가 많거나 이미 심뇌혈관질환이 있는 경우에는 무리한 운동으로 오히려 다치거나 심장병 증상이 악화될 수도 있기 때문에 운동 시작 전에 주의해야 할 점들을 의사와 상담하는 것이 좋으며, 경우에 따라 운동부하검사 등이 필요할 수도 있습니다.
- 낙상의 위험을 가진 사람은 몸의 균형 감각을 개선하고 유지할 수 있는 운동이 도움이 됩니다.
- 자신에게 맞는 운동을 찾아 지속적으로 하는 것뿐만 아니라 일상생활에서도 적절한 신체 활동을 하는 것이 좋습니다.

규칙적으로 운동합니다.

- ▶ 유산소 운동을 일주일에 3회 이상 규칙적으로 합니다.
 - 운동 전과 후에는 반드시 준비 운동과 정리 운동을 합니다.
 - 빠르게 걷기, 조깅, 수영, 자전거 타기와 같은 유산소 운동을 중간 강도(숨이 약간 찬 느낌이 있으나 말을 할 수 있는 정도, 분당 3~6 칼로리 소모)로 합니다.
 - 운동을 한 번 할 때 30분 이상, 일주일에 150분 이상 규칙적으로 운동합니다.
- ▶ 근육 강화 운동도 적절하게 병행합니다.
 - 일주일에 2회 이상 중간 강도 이상의 근육 강화 운동을 하면 지질 대사 개선과 더불어 추가적인 효과를 얻을 수 있습니다.
 - 근육 강화 운동을 할 때는 몸의 주요 근육들(다리, 엉덩이, 등, 가슴, 복부, 어깨, 팔, 등)을 모두 포함하는 것이 좋습니다.
 - 근육 강화 운동을 할 때에는 한 동작을 8~12회씩 반복하는 것이 효과적입니다.
 - 근육 강화 운동으로 턱걸이, 윗몸 일으키기, 팔 굽혀 펴기, 웨이트 트레이닝을 합니다.

TIP 운동을 통하여 소모되는 열량

운동 종류	분당 소모 칼로리(cal)	시간당 소모 칼로리(cal)
볼링, 도보(< 5 km/hr)	3~4	180~240
도보(> 5 km/hr), 골프, 사이클/자전거(10 km/hr)	4~5	240~300
테니스(복식), 에어로빅(약하게), 배드민턴, 사이클/자전거(13 km/hr)	5~6	300~360
수영(약하게), 농구, 사이클/자전거(16 km/hr)	6~7	360~420
테니스(단식), 스케이트, 사이클/자전거(18 km/hr)	7~8	420~480
조깅(8 km/hr), 에어로빅(강하게), 축구, 계단 오르기, 수영(중간 정도), 사이클/자전거(19 km/hr)	8~10	480~600

일상생활 속에서 신체 활동을 늘립니다.

▶ 적정 체중을 유지하기 위하여 일상생활 속에서 신체 활동을 늘리는 요령을 숙지합니다.

- 운동 장비가 갖추어진 동네 공원에서 매일 30분씩 신체 활동을 합니다.
- 보건소나 지역 사회에서 제공하는 운동 프로그램이 있을 경우 프로그램에 참여합니다.
- 규칙적인 운동이 어렵다면 일상생활 속에서 신체 활동량을 늘려 갑니다.
- 운동을 별도로 한다고 하더라도 일상생활에서 신체 활동의 양이 너무 적으면 좋지 않으므로 적절한 신체 활동을 하도록 합니다.

TIP 일상생활 속에서 신체 활동을 늘리는 방법

- 출퇴근 시 한 정거장 먼저 내려 걷기
- 자동승강기나 에스컬레이터 대신 계단을 이용하기
- 가까운 거리는 걷거나 자전거를 이용해 이동하기
- 차를 가지고 출근할 경우 차량 5부제를 준수하기
- 회사에서 화장실이나 휴게실 이용 시 아래층이나 위층으로 가기
- 휴식 시간에 동료들과 주변을 거닐며 대화하기
- 사무실에 앉아 있을 때는 허리와 가슴을 펴고 배에 힘을 주고 앉기
- 술을 마시는 등 주로 앉아서 하게 되는 회식보다 등산이나 봉사활동 등의 건전하면서도 활동적인 모임 갖기
- 혼자 또는 가족이 함께 즐길 수 있는 활동적인 취미(운동) 만들기
- 전화 통화는 서서 하거나 움직이면서 하기
- 텔레비전을 볼 때에는 스트레칭을 하거나 고정식 자전거 타기
- 지하철이나 버스정류장에서 가볍게 움직이면서 기다리기

자주하는 질문

Q

운동은 하루 중 언제 하는 것이 좋은가요?

A

일반적으로 아침 시간에 유산소운동을 꾸준히 하게 되면 식욕을 억제할 뿐만 아니라 신진대사를 증진시켜 체지방을 빨리 태우는 데 효과적이라고 알려져 있습니다. 또한 저녁 시간에 운동을 하게 되면 상대적으로 고강도의 운동을 할 수 있어서 근육량을 늘리는 데 효과적이라고 알려져 있습니다. 그러므로 이상지질혈증만을 놓고 보면 아침 시간 운동이 더 좋을 것 같기도 합니다. 그렇지만 근육은 운동을 통해 한번 자극을 받으면 이후 48~72시간 동안 운동에 대한 기억을 하게 되므로 운동을 언제 하는지가 중요하기 보다는 자신의 생활 패턴에 맞는 시간대에 규칙적으로 꾸준히 계속하는 것이 훨씬 중요합니다.

Q

하루에 운동을 여러 번 하는 것이 더 효과적인가요?
식전 운동과 식후 운동에 따른 차이가 있나요?

A

운동을 꾸준히 하는 사람과 그렇지 않은 사람은 식사 후에 흡수된 영양분들(탄수화물, 지질)이 저장되는 경로에 차이가 있습니다. 운동을 꾸준히 하는 경우에는 우선적으로 근육에 저장되는 부분이 많아져서 운동 시에 에너지원으로 소모되는 반면, 운동을 하지 않는 경우에는 지방이나 간에 저장되는 부분이 많아져 대사 지표에 영향을 줄 수 있습니다. 한 연구에서는 식사 때마다 운동을 나누어서 한 경우와 하루에 한번 운동을 한 경우를 비교하였는데 대사 지표는 운동 횟수나 식전, 식후 운동에 따라 차이가 난다고 보다는 하루 동안의 총 운동량과 비례하여 개선되는 결과를 보였습니다. 그러므로 하루에 여러 번 시간을 내어 운동을 할 수 없는 사람도 하루에 한번 정기적으로 규칙적인 운동을 한다면 운동을 위해 식사 때마다 시간을 내어 운동한 사람과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

03

셋째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다.

실천 항목

보통 근거 👍 👍

- 자신에게 해당되는 표준 체중과 적절한 허리둘레를 알고 적정 체중을 유지합니다.
- 체중이 표준 체중 이상으로 많이 나가는 사람은 체중을 감량합니다.



관련 상식 들여다보기

- 체중이 표준 체중 이상으로 많이 나가면 이상지질혈증, 고혈압, 제2형 당뇨병, 관상동맥질환 등에 걸릴 위험이 높아지고 이로 인 한 사망 및 심혈관계질환 사망률도 높입니다.
- 체중이 표준 체중 이상으로 많이 나가면 이것이 이상지질혈증을 일으키는 위험 요인으로 작용하게 됩니다. 그중에서도 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증과 밀접하게 관련되어 있습니다.
- 체중이 표준 체중 이상으로 많이 나가는 사람이 체중을 줄이면 이상지질혈증도 좋아지므로 체중을 감량하는 것이 좋습니다.
- 식사 조절과 신체 활동 늘리기를 함께 진행해야 체중 조절을 할 수 있을 뿐만 아니라 한 번 줄인 체중을 오래 유지할 수도 있습니다.

실천 방법 알기

자신에게 해당되는 표준 체중과 적절한 허리둘레를 알고 적정 체중을 유지합니다.

▶ 자신에게 해당되는 표준 체중을 정확히 알고 표준 체중에 맞춰 체중을 유지하도록 합니다.

- 남자의 표준 체중(kg) = 키(m) × 키(m) × 22
- 여자의 표준 체중(kg) = 키(m) × 키(m) × 21

TIP 키가 175 cm인 남자의 표준 체중 계산 방법

1.75(m) × 1.75(m) × 22 = 67.375 kg으로, 표준 체중은 약 67 kg입니다.

▶ 자신의 체질량 지수(BMI)를 알고 비만에 해당하는 수치인지 확인합니다.

- 체질량 지수 = 체중(kg) ÷ [키(m) × 키(m)]
- 비만 전단계 23.0-24.9 kg/m²
- 비만 25.0 kg/m² 이상

(출처: 대한비만학회, 비만 진료지침, 2022.)

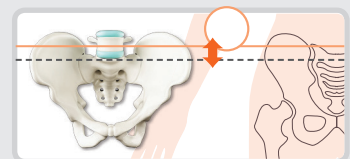
▶ 적정 허리둘레 목표치를 알고 자신의 허리둘레가 복부 비만에 해당하는지 확인합니다.

- 남성 90 cm(35인치) 미만 유지
- 여성 85 cm(33인치) 미만 유지

TIP 허리둘레 측정 방법

① 양발을 25~30 cm 정도 벌리고 서서 체중을 고루 분산시킵니다.

② 숨을 편안히 내쉬 상태에서 골반뼈의 위쪽 부분에서 가장 앞으로 돌출된 부위에서 3 cm 윗 부위를 줄자로 측정합니다.



③ 복부의 피하지방이 과도하여 허리와 겹쳐지는 경우는 똑바로 선 상태에서 피하지방을 들어올려 측정하고, 줄자가 피부를 강하게 누르지 않도록 느슨하게 하여 0.1 cm 단위까지 측정합니다.

참고문헌: 대한비만학회, 비만치료지침 2014.

체중이 표준 체중 이상으로 많이 나가는 사람은 체중을 감량합니다.

- ▶ 체중 감량 목표를 정하여 운동을 하고 일상생활 속 신체 활동을 늘립니다.
 - 비만일 경우 현재보다 체중을 5~10% 정도 감량하는 것을 1차적 목표로 정하되, 주당 0.5~1 kg 정도 감량하는 것이 적당합니다.
 - 운동 전과 후에는 반드시 준비운동과 정리운동을 합니다. 유산소 운동과 근력 강화 운동을 병행하여 실시하되 점차적으로 시간, 빈도, 강도를 늘려 나갑니다.
 - 일상생활 중에서 신체 활동을 늘리는 요령을 숙지합니다.(22페이지 참고)
- ▶ 운동과 함께 식이 요법도 병행합니다.
 - 자신의 활동량에 따라 하루 필요 열량을 계산해 보고, 이에 맞추어 식단을 조절합니다.
 - 신체 활동이 거의 없는 경우: 표준 체중(kg) × 25~30 칼로리
 - 보통 정도로 활동하는 경우: 표준 체중(kg) × 30~35 칼로리
 - 신체 활동이 많은 경우: 표준 체중(kg) × 35~40 칼로리
 - 당분이나 기름기가 많은 음식의 섭취를 피하고, 영양소를 매일 골고루 섭취하는 균형 잡힌 식사를 합니다.(15페이지 참고)
 - 체중 감량을 위하여 자신에게 맞는 운동과 식이 요법을 찾아 장기적으로 실천해 나갑니다. 또한 체중 감량 후에도 건강한 생활 습관이 유지되도록 합니다.
- ▶ 교육 프로그램이나 전문가의 도움을 받습니다.
 - 보건소나 지역 사회에서 제공하는 비만 교육 프로그램에 참여합니다.
 - 비만이 심하거나 식사 및 운동 요법으로 체중 감소가 시행되거나 유지되지 않는다면 병·의원을 방문해서 식사와 운동에 대해 의사와 전문적인 상담을 하고 해당 권고 내용을 따라 지속적인 관리를 합니다.

자주하는 질문

Q

좋은 HDL-콜레스테롤을 높이는 데 운동이 도움이 되나요?

A

혈중 지질 수치를 낮추기 위해서는 운동뿐만 아니라 몸의 활동량 자체를 늘려야 합니다. 운동은 좋은 HDL-콜레스테롤을 올릴 뿐만 아니라 중성 지방 수치나 나쁜 LDL-콜레스테롤 수치도 낮춥니다. 특히, 좋은 HDL-콜레스테롤 수치가 낮은 사람일수록 운동에 의한 효과가 더욱 크다고 알려져 있습니다.

하지만 이러한 효과를 보기 위해서는 상당히 많은 양의 운동을 해야 합니다. 즉, 최소한 한 번에 30분, 일주일에 3회 이상 중간 강도 이상의 운동을 시행해야 합니다.

운동이 이상지질혈증을 교정한다는 충분한 근거가 있으므로 적절한 식사 요법과 함께 충분한 운동을 한다면 더욱 좋은 효과를 기대할 수 있을 것입니다.

Q

복부 비만을 줄이는 방법이 따로 있나요?

A

복부는 쉽게 살이 찌 수 있는 부위이므로 사람들은 복부 비만을 줄이는 방법을 찾게 됩니다. 그렇지만 일반적으로 비만에서 특정 부위만을 개선하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 게다가 복부에 행하는 주사 요법이나 지방 흡입술 등은 의학적인 근거가 희박한데다가 실제로 개선에 큰 도움이 되지 않는 경우가 대부분입니다. 그러므로 복부의 비만을 줄이는 특별한 방법을 찾기보다는 전체적인 비만을 치료하면서 자연히 복부 비만도 줄도록 해야 합니다.

비만 치료를 위해서는 식사 조절 및 운동 요법을 시행하면서 이것만으로 원하는 결과를 얻지 못할 경우 약물 요법이 필요할 수 있습니다.

04

넷째,
금연합니다.

실천 항목

- 금연을 합니다.

높은 근거 🍎🍎🍎



관련 상식 들여다보기

- 흡연은 심뇌혈관질환인 뇌졸중, 협심증, 심근경색증, 말초혈관질환, 복부 동맥류의 위험을 높입니다.
- 흡연량이 많을수록, 흡연 기간이 길수록, 심뇌혈관질환이 더 잘 생깁니다. 직접흡연뿐만 아니라 간접흡연도 예외는 아닙니다.
- 이상지질혈증 환자가 흡연을 하는 경우, 이러한 심뇌혈관질환 합병증은 더 심각하고 빠르게 발생하며 심해집니다.
- 심뇌혈관질환의 예방을 위해서는 직접흡연뿐만 아니라 간접흡연을 포함한 모든 형태의 흡연을 중단하는 것이 좋습니다.

금연을 합니다.

▶ 전문가와 상담합니다.

- 흡연은 니코틴 중독이므로 혼자서 금연에 성공하기는 어려운 경우가 많습니다. 이러 한 경우는 전문 의료진과의 금연 상담이 필요합니다.
- 각 지역 보건소와 병원의 금연 클리닉을 방문하거나, 방문이 어렵다면 금연 상담 전화 (1544-9030) 또는 금연 길라잡이 웹사이트(<http://www.nosmokeguide.or.kr>) 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

▶ 나에게 맞는 금연 방법을 선택합니다.

- 니코틴 중독을 완화하는 금연 보조제나 금연 약물을 사용하면 금연하는 데 도움이 됩니다.
- 단기간에 금연하는 것은 어려운 일이므로 주변의 도움이 필요합니다.
- 금연 의지를 주변에 적극적으로 알리고, 술자리나 흡연자와 만나는 자리는 피하는 것이 좋습니다.
- 담배는 천천히 끊는 것보다 한 번에 끊는 것이 더 효과적입니다.

▶ 금연 성공 후에도 지속적으로 관리합니다.

- 금연 후에는 체중이 늘 수 있으므로 이를 방지하기 위해 운동 및 식사 요법을 병행해야 합니다.
- 재흡연은 금연 후 3개월 이내에 많이 일어납니다. 특히, 배가 고프거나 스트레스를 받을 때, 외로움을 느낄 때, 피로할 때 재흡연의 위험성이 높아지므로 주의가 필요합니다.
- 음주는 흡연을 부추깁니다. 과도한 음주는 재흡연 방지를 위해 피하는 것이 좋습니다.

자주하는 질문

Q

금단 증상은 언제, 어떻게 나타나나요?

A

금단 증상은 담배를 끊은 후 수 시간 이내 나타나서 1주일 이내에 최고조에 이르고 이후 호전된 상태로 평균 2~4주간 지속됩니다.
흔한 증상으로는 기침, 가래, 갈증, 짜증, 두통, 집중력 장애, 불안, 불면, 배변 장애, 졸음, 식욕 증가, 우울 등이 있으며, 우울 및 집중력 장애 등의 증상은 4주 이내에 좋아지지만 흡연에 대한 갈망은 수주에서 수개월간 지속될 수 있습니다.

Q

금연이 콜레스테롤 조절에 도움이 되나요?

A

흡연은 좋은 HDL-콜레스테롤을 감소시키고 저산소증을 일으키며 혈관벽을 수축시키고 손상시켜 심뇌혈관질환 위험도를 급격히 증가시킵니다.
반대로 금연을 하면 좋은 HDL-콜레스테롤이 증가하고 저산소증이 해소되면서 혈관이 건강해집니다.
한 갑 정도 흡연하던 사람이 금연을 하면 좋은 HDL-콜레스테롤이 5% 정도 증가하여 콜레스테롤 조절에 긍정적인 영향을 미칩니다. 협심증, 심근경색, 뇌졸중(뇌경색)과 같은 심뇌혈관질환의 위험도 더불어 감소합니다.

05

다섯째, 절주합니다.

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 하루 1~2잔 이내로 절주합니다.
- 가급적이면 금주를 합니다.



관련 상식 들여다보기

- 적정 음주량은 술 종류에 관계없이 술을 제공하는 잔을 기준으로 하루 1~2잔 이내입니다.
- 적정량 이상의 과한 음주는 중성 지방 수치를 올리는 것 이외에도 고혈압, 심근병증, 췌장염 등을 일으킬 수 있으므로 피합니다. 그러므로 중성 지방이 높은 경우에는 금주하는 것이 좋습니다.
- 간질환이 있는 경우에는 금주하는 것이 좋습니다. 간질환 환자가 하루 두 잔 이상의 술을 마시면 중성 지방 수치가 올라가고 간에도 좋지 않습니다.
- 원래 술을 마시지 않는 사람에게 이상지질혈증 관리 혹은 심뇌혈관질환의 예방을 위해 음주를 권고하지는 않습니다.

실천 방법 알기

하루 1~2잔 이내로 절주합니다.

- ▶ 적정 음주량은 술의 종류에 관계없이 술의 해당 주류 잔을 기준으로 하루 1~2잔 이내입니다.
- ▶ 폭음, 과음, 잦은 술자리를 피합니다.
 - 서로 술을 억지로 권하지 않으며, 술자리는 1차로 가볍게 마무리합니다.
 - 술잔 돌리기, 폭탄주 만들기 등은 금물입니다.
 - 음주를 원치 않을 때에는 확실하게 거절 의사를 표현하며 절주 의지를 적극적으로 주변에 알립니다.
- ▶ 음주를 대신할 수 있는 다른 여가 활동, 스트레스 관리법을 찾습니다.
 - 육체적, 정신적 긴장감을 이완하고 스트레스를 관리하기 위해 호흡법, 명상, 요가, 혹은 본인에게 맞는 운동 등을 하면서 건전한 여가 활동, 취미 활동을 즐깁니다.

가급적이면 금주를 합니다.

- ▶ 금주 계획 및 금주를 실천하고자 하는 의지를 주변에 적극적으로 알리고 도움을 요청합니다.
 - 가족들이나 가까운 친구들 앞에서 금주 서약서를 작성해 보는 것도 좋은 방법입니다.
- ▶ 전문가의 도움을 받을 수도 있습니다.
 - 전문 의료진과 상담을 할 수 있습니다. 스스로의 힘으로 절제가 어렵다면, 전문 의료진과 상의하여 금주를 도와주는 항갈망제 등의 보조 약제를 사용해 볼 수도 있습니다.
 - 가까운 보건소나 의료 기관의 금주 클리닉, 알코올 클리닉, 알코올 센터 등의 도움도 받을 수 있습니다.

자주하는 질문

Q

술이 좋은 HDL-콜레스테롤 수치를 올리나요?

A

술은 좋은 HDL-콜레스테롤 수치를 올릴 수 있으나 마시는 술의 양이 많으면 알코올 자체가 가진 칼로리를 많이 섭취하게 됩니다. 그리고 대개의 경우 술만 마시는 것이 아니라 고지방, 고칼로리 안주를 같이 먹게 되기 때문에 결과적으로 나쁜 LDL-콜레스테롤 수치를 올릴 수 있으니 주의가 필요합니다. 또한 지속적인 음주는 간기능 이상을 초래할 수 있습니다.

부록

1. 개발 개요

개발자	2023 이상지질혈증 임상진료지침 제정위원회 및 개정위원회
사용자	일반인 및 이상지질혈증 환자
외부 검토	사용자 50명(일반인, 보건의료계 종사자, 개원의)
목적	근거를 기반으로 이상지질혈증의 예방·관리 수칙과 이를 실천하기 위한 방법 그리고 자주하는 질문에 대하여 꼭 필요한 정보를 제공함으로써 이상지질혈증과 관련된 위험 요인을 보다 쉽게 이해하도록 하고, 건강한 생활을 유지하는 것이 중요하다는 인식을 제고하기 위함.
개발 영역	이상지질혈증 소개, 이상지질혈증에 대해 자주하는 질문, 이상지질혈증의 예방과 관리를 위한 5대 생활 수칙: 첫째, 건강한 식습관을 가집니다. 둘째, 규칙적으로 운동합니다. 셋째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다. 넷째, 금연합니다. 다섯째, 절주합니다.
예상 편익	장기적으로 심혈관질환 발생 예방 및 감소, 이상지질혈증 인지율 향상, 합병증 발생 예방 및 감소

2. 개발 방법

- 의사용 진료지침(일차 의료용 근거기반 이상지질혈증 권고 요약본 2023)과 같은 근거 자료(Same Evidence Body)를 사용하였고, 이를 바탕으로 다학제 전문가들에 의해 개발됨.

3. 사용자 의견 조사 및 결과의 반영

- 의견 조사 기간: 2016년 10월 24일 ~ 2016년 11월 8일
- 이 지침의 주 사용자 50명(일반인, 보건의료계 종사자, 개원의)을 대상으로 「나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보」의 필요도와 활용도에 대한 의견조사를 수행함.

4. 편집의 독립성

- 재정 지원: 질병관리본부 만성질환관리과의 「만성질환 예방관리 가이드라인 개발 기술 지원」 사업의 일환으로 2016년도 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받았으며, 재정 지원자가 본 교육자료의 내용이나 개발 과정에 직접적인 혹은 잠재적인 영향을 주지 않음.
- 진료지침 개발에 참여한 모든 구성원들의 잠재적인 이해상충 관계유무를 확인하기 위하여 지난 2년 동안 지침 개발 내용과 관련된 주제로 1,000만 원 이상의 후원을 받거나, 사례금을 받고 자문을 한 경우, 특정 기관 혹은 제약회사의 지분 이익이나 스톡옵션과 같은 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리를 제공받는 경우, 특정 기관 혹은 제약회사에서 공식/비공식적인 직함을 가지고 있는지의 여부까지 자기기입식 조사표를 개발하여 조사한 결과 상충되는 혹은 잠재적인 이해관계가 있는 경우가 없음.

5. 갱신의 원칙과 방법

- 새로운 약제, 치료법 등에 대한 양질의 근거가 명백한 경우에만 부분적으로 권고를 수정, 보완 혹은 삭제하는 방법으로 매 3~5년마다 의사용 진료지침을 갱신할 경우 같은 근거 자료를 사용하여 본 「나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보」의 갱신을 계획하고 있음.

6. 관련 정보 찾아보기

· 일차 의료용 근거기반 디지털 가이드라인

- (www.digitalcpg.kr) 누리집에 접속



7. 집필진

· 이상지질혈증 임상진료지침 제정위원회 2023

구분	추천 학회명	성명	소속	전문 과목
위원장	대한내과학회	김상현	서울대학교 보라매병원	순환기내과
	한국지질·동맥경화학회			
위원	대한고혈압학회	조상호	한림의대 평촌성심병원	순환기내과
위원	대한당뇨병학회	전숙	경희의대 경희대병원	내분비내과
위원	대한가정의학회	박현아	인제의대 상계백병원	가정의학과
위원	대한개원의협의회	경문배	삼성탑가정의학과의원	가정의학과
간사	대한의학회	신인순	대한의학회 연구센터	보건학(방법론)

· 이상지질혈증 임상진료지침 개정위원회 2023

구분	학회구분	성명	소속	전문 과목
위원장	대한내과학회	김상현	서울대학교 보라매병원	순환기내과
	한국지질·동맥경화학회			
위원	한국지질·동맥경화학회	최성훈	한림의대 강남성심병원	순환기내과
위원	한국지질·동맥경화학회	박재형	고려의대 안암병원	순환기내과
위원	대한고혈압학회	조상호	한림의대 평촌성심병원	순환기내과
위원	대한고혈압학회	이찬주	연세의대 세브란스병원	심장내과
위원	대한고혈압학회	원호연	중앙의대 중앙대병원	순환기내과
위원	대한당뇨병학회	전숙	경희의대 경희대병원	내분비내과
위원	대한내분비학회	정경연	울지의대 노원율지병원	내분비내과
위원	대한비만학회	강지현	건양의대 건양대병원	가정의학과
위원	대한뇌졸중학회	박광열	중앙의대 중앙대병원	신경과
위원	대한가정의학회	박현아	인제의대 상계백병원	가정의학과
위원	대한가정의학회	김종우	인제의대 상계백병원	가정의학과
위원	대한신장학회	유태현	연세의대 세브란스병원	신장내과

· 대한의학회 임상진료지침 연구사업단 2023

구분	추천 학회명	성명
회장	정지태	대한의학회 회장, 고려대 병원
단장	이진우	대한의학회 부회장, 연세대 병원
부단장	용환석	대한의학회 정책이사, 고려대 병원
연구위원	신인순	대한의학회 연구센터 실장
연구원	김다솔	대한의학회 연구센터
연구원	유경미	대한의학회 연구센터
연구원	전정진	대한의학회 연구센터
연구원	백중서	대한의학회 연구센터

8. 참고문헌

1. 대한의학회·질병관리본부. 일차 의료용 근거기반 이상지질혈증 임상진료지침. 2023.
2. 대한의학회·질병관리본부. 일차 의료용 근거기반 이상지질혈증 권고 요약본. 2023.
3. 대한비만학회. 비만진료지침. 2014.
4. 대한비만학회. 비만진료지침. 2022.

개발 참여 학회

이상지질혈증 예방과 관리 정보 개발 및 집행

대한의학회

이상지질혈증 예방과 관리 정보 개발 주관학회

한국지질·동맥경화학회

이상지질혈증 예방과 관리 정보 개발 참여학회

대한가정의학회

대한개원의협의회

대한고혈압학회

대한내과학회

대한내분비학회

대한뇌졸중학회

대한당뇨병학회

대한비만학회

대한신장학회

나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보

- 발 행 일: 2023년 12월 31일
- 펴 낸 곳: 대한의학회 · 질병관리청
- 개발 집필: 대한의학회 이상지질혈증 임상진료지침 제정 및 개발위원회
- 기획 편집: 대한의학회 임상진료지침 연구사업단
서울특별시 서초구 반포대로 14길 42(서초동) 하이앤드빌딩 6층(우.06653)
Tel: 02-6952-9602/ E-mail: guidelines@kams.or.kr
- 디 자 인: 플레이니트 Tel: 070-3446-9922

「나와 가족을 위한 이상지질혈증 예방과 관리 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영지원」 사업의 하나로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었습니다.



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청



9 791168 603608

ISBN 979-11-6860-360-8 (PDF)

비매품/무료

95510